

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências - UHMR
Versão consolidada para validação técnica e instrução do planejamento da
contratação

Órgão	Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES-MT
Unidade requisitante	A ser formalmente indicada no processo administrativo
Área técnica proponente	Equipe de Planejamento da Contratação a ser designada
Abrangência	Todo o território do Estado de Mato Grosso
Versão/data	Revisão 2.1 - 28 de setembro de 2026

Cuiabá - MT
28 de setembro de 2026

Nota de utilização

Finalidade do documento

Este ETP organiza a necessidade, avalia alternativas e propõe a arquitetura inicial da contratação. Não substitui a designação formal da equipe de planejamento, a pesquisa de preços, os pareceres das áreas técnicas, a análise jurídica nem a aprovação da autoridade competente. Os quantitativos e parâmetros assinalados como indicativos deverão ser confirmados antes da elaboração do Termo de Referência.

Síntese da decisão recomendada

Tema	Recomendação preliminar	Justificativa
Objeto	Capacidade continuada de prontidão, mobilização, instalação, operação, manutenção e desmobilização de UHMR.	Contrata resultado operacional e disponibilidade, não apenas tendas e equipamentos.
Escalonamento	N0 de prontidão; N1 a N4 referenciais, com configuração personalizada e independente.	Permite adequar custo, prazo e capacidade à gravidade do evento.
Núcleo de referência	N3 com pelo menos 20 leitos de internação, até 30, quatro posições críticas e uma sala cirúrgica.	Mantém compatibilidade funcional com a classificação EMT Tipo 2 da OMS, sem exigir certificação internacional como condição automática.
Modelo de fornecimento	Integrador único para infraestrutura, sistemas críticos e logística; equipes clínicas em módulo separável.	Reduz falhas de interface e preserva flexibilidade jurídico-assistencial.
Modelo econômico	Mensalidade de prontidão + mobilização + transporte + instalação + diária operacional + consumíveis + expansão.	Evita pagamento integral de capacidade não utilizada e torna a medição auditável.
Transporte	Rodoviário estadual como requisito; aerotransporte civil desejável; padrão militar apenas opcional.	Evita custo e restrição competitiva sem benefício proporcional ao contexto estadual.
Autonomia	Autonomia inicial mínima de 72 horas e plano de reabastecimento para operação prolongada.	Equilibra mobilidade, peso, segurança e continuidade.
Aceitação	Prova de conceito, FAT/SAT e exercício anual completo.	Comprova integração real, desempenho e repetibilidade da solução.

Sumário

1. Identificação e contexto administrativo	14. Estimativas de quantidades
2. Descrição da necessidade	15. Parcelamento e estratégia de contratação
3. Objetivos da contratação	16. Resultados pretendidos
4. Alinhamento institucional e normativo	17. Modelo econômico e pesquisa de preços

1. Identificação e contexto administrativo	14. Estimativas de quantidades
5. Cenários de emprego e estimativa da demanda	18. Providências prévias à contratação
6. Requisitos da contratação	19. Contratações correlatas e interdependentes
7. Levantamento de mercado e análise de alternativas	20. Sustentabilidade e impactos ambientais
8. Solução recomendada	21. Riscos preliminares
9. Arquitetura modular e níveis de ativação	22. Governança, fiscalização e medição
10. Ciclo operacional e logística	23. Conclusão de viabilidade
11. Comunicações, tecnologia e proteção de dados	24. Deliberações necessárias
12. Equipes e organização do trabalho	Referências
13. Modelo de execução e níveis de serviço	Anexos técnicos A a F

Diretrizes de prontidão e acionamento

Revisão 2.1 de 28/09/2026. Minuta para validação institucional. As diretrizes abaixo integram o planejamento e devem orientar os requisitos e formulários desta peça.

N0 e remuneração da prontidão

N0 permanece como prontidão, sem assistência ativa. A mensalidade remunera a capacidade contratada mantida disponível mesmo sem utilização, mediante aceite inicial e comprovação mensal de inventário, conservação, testes, manutenção, equipe técnica e meios de mobilização. A indisponibilidade será registrada e terá tratamento de medição conforme critérios contratuais. A permanência da mensalidade durante missões exige demonstração das obrigações efetivamente mantidas e exclusão de custos duplicados nas parcelas variáveis.

Configuração personalizada da missão

N1 a N4 são referências de planejamento, sem obrigação de ativação cumulativa. Cada missão poderá selecionar módulos isolados, combinar módulos ou adotar quantitativos diferentes das faixas referenciais, dentro do objeto, dos quantitativos contratados e dos requisitos de segurança. São exemplos: dez leitos com suportes dimensionados; somente laboratório; somente medicamentos e insumos. A configuração efetiva e o nível de referência serão registrados separadamente. Não se presumem cirurgia, internação, equipes ou infraestrutura não solicitadas. As dependências técnicas indispensáveis serão justificadas e dimensionadas, inclusive quando fornecidas pela rede local.

Responsabilidade pela manutenção

A contratada executará e custeará manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibrações aplicáveis, testes, peças, mão de obra e substituição dos equipamentos necessários à disponibilidade. Esses encargos integram os preços contratados, inclusive durante períodos sem uso, sem cobrança adicional à SES-MT por manutenção ordinária. O plano de manutenção seguirá fabricante, risco e requisitos técnicos, com registros por equipamento, datas, responsável e evidências. A manutenção programada não poderá reduzir a capacidade garantida sem cobertura equivalente e comunicação à fiscalização.

Fornecimento exclusivo de medicamentos

Poderá ser acionado somente o fornecimento de medicamentos ou insumos previamente especificados e precificados, sem montagem hospitalar. A solicitação discriminará item, apresentação, concentração quando pertinente, unidade, quantidade, destino, prazo, lote e validade no recebimento, condições de conservação e responsável pelo aceite. Armazenagem, transporte, cadeia de frio quando aplicável, rastreabilidade, regularidade sanitária e responsabilidade farmacêutica deverão ser assegurados. Estoque reservado, mercadoria fornecida e reposição serão distinguidos na medição. Perdas por vencimento ou conservação imputáveis à contratada não serão repassadas à SES-MT. A relação de itens e o parcelamento ainda dependem de planejamento e validação formal.

Competência e fundamentação do acionamento

Compete ao Secretário de Estado de Saúde autorizar o acionamento e a configuração da missão, mediante Ordem de Acionamento fundamentada em documentação técnica, análise de

risco e avaliação de cenários. A instrução conterá identificação do evento, demanda estimada, capacidade residual da rede, alternativas, justificativa, módulos ou itens, quantidades, dependências, local, prazo, duração, estimativa de custo e disponibilidade contratual e orçamentária. As áreas técnicas, inclusive CIEVS/COES quando envolvidos, subsidiam a decisão. A fiscalização acompanha a execução e não substitui a autorização do Secretário. Ampliação, redução e encerramento serão formalizados com justificativa técnica e decisão do Secretário, preservada a interrupção imediata de atividade insegura pela fiscalização.

Medição por configuração e aceite

A medição separará mensalidade N0, serviços efetivamente acionados e aceitos e medicamentos/insumos fornecidos. Cada item terá unidade, quantidade, preço, período, origem e evidência. Suportes compartilhados serão contabilizados uma única vez. Manutenção ordinária, perdas imputáveis à contratada e itens já pagos não gerarão nova cobrança. Para fornecimento exclusivo, não incidem montagem, diária hospitalar ou desmobilização física inexistentes. O aceite será de recebimento dos produtos. Para laboratório isolado ou assistência, aplicam-se comissionamento e liberação compatíveis com a atividade. Preços, glosas e SLAs permanecem sujeitos a pesquisa de mercado e validação antes do edital.

1. Identificação e contexto administrativo

Elemento	Definição inicial
Objeto em estudo	Contratação de solução integrada, modular, escalável e mobilizável de Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências - UHMR.
Natureza	Serviço continuado de disponibilidade e prontidão, com fornecimento de bens em regime de locação/cessão de uso, logística, instalação, manutenção, suporte e operação quando acionado.
Abrangência geográfica	Municípios e regiões de saúde de Mato Grosso; mobilização interestadual somente quando autorizada e prevista.
Vigência sugerida para estudo	Prazo plurianual suficiente para amortização, prontidão e manutenção, sujeito à modelagem econômica e jurídica.
Forma de acionamento	Ordem de Acionamento emitida pelo Secretário de Estado de Saúde, fundamentada em documentação técnica, análise de risco e cenários, com subsídios do COE/COES quando ativado.
Classificação do documento	Estudo Técnico Preliminar, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e regulamentação estadual aplicável.

A contratação poderá integrar processo maior referente à gestão ou operação de unidade hospitalar. Nessa hipótese, os requisitos da UHMR devem constituir obrigação autônoma, mensurável e acionável, com preços unitários, responsabilidades e níveis de serviço próprios, evitando que a capacidade de resposta fique diluída em cláusulas genéricas do contrato hospitalar.

2. Descrição da necessidade

A SES-MT necessita de capacidade assistencial temporária que possa ser mobilizada com rapidez quando a rede existente estiver interrompida, danificada, isolada, saturada ou inadequada para absorver aumento súbito da demanda. A necessidade compreende eventos climáticos e ambientais, emergências de saúde pública, incidentes com múltiplas vítimas, desastres tecnológicos, colapso estrutural ou funcional de estabelecimentos, surtos e epidemias, grandes eventos e situações de desassistência territorial.

O problema não é apenas a ausência de tendas. Uma resposta hospitalar temporária depende de integração entre infraestrutura, energia, climatização, água, saneamento, gases medicinais, equipamentos, diagnóstico, medicamentos, telecomunicações, sistemas de informação, recursos humanos, suprimentos, segurança, manutenção e comando. A contratação fragmentada e acionada somente após o desastre tende a aumentar o tempo de resposta, produzir incompatibilidades e transferir riscos de interface à Administração.

2.1 Problema público a resolver

Enunciado do problema

Como assegurar, em qualquer região de Mato Grosso, capacidade hospitalar temporária segura, interoperável e proporcional ao evento, com mobilização rápida, autonomia inicial, continuidade assistencial e custo controlado, quando a infraestrutura local não puder responder adequadamente?

2.2 Consequências da não contratação

- atraso na expansão da capacidade assistencial e aumento de risco de óbitos evitáveis;
- sobrecarga de hospitais, pronto-atendimentos, SAMU e regulação;
- contratações emergenciais sucessivas, com menor padronização e previsibilidade de preços;
- dependência de estruturas de outras esferas sem garantia de disponibilidade;
- perda de continuidade em áreas isoladas ou atingidas por desastres;
- instalações temporárias sem integração entre energia, climatização, gases, WASH, TI e equipamentos;
- dificuldade de comando, rastreabilidade, fiscalização e responsabilização.

2.3 Caracterização territorial e evidências estaduais

Mato Grosso reúne 142 municípios distribuídos em 16 Regiões de Saúde, possui população estimada de 3.950.330 habitantes em 2026 e território de aproximadamente 903,2 mil km². A combinação entre grande extensão territorial, baixa densidade populacional, três biomas, longas distâncias rodoviárias e concentração de serviços especializados exige que a resposta temporária seja móvel, autônoma e integrada à regionalização do SUS. A matriz logística deverá utilizar distâncias e tempos rodoviários reais, inclusive sazonalidade dos acessos, e não apenas distância em linha reta (IBGE, 2026; SES-MT, 2026).

2.3.1 Incêndios florestais e operações prolongadas

O Relatório Final da Temporada de Incêndios Florestais de 2025 registrou 10.968 focos de calor no Estado, distribuídos entre Amazônia, Cerrado e Pantanal, e 3.582 ocorrências de incêndios florestais atendidas no ano. O planejamento previu 68 Instrumentos de Resposta Temporários

e foi ampliado para 72 durante o período crítico. O relatório documenta, ainda, operação em área aproximada de 45.080,01 hectares, com emprego de 50 militares do CBMMT, quatro militares da Força Nacional, aeronave, caminhões-pipa, viaturas e maquinário. Esses registros demonstram dispersão territorial, missões prolongadas, dificuldade de acesso e necessidade de apoio assistencial, energético, logístico e de comunicações em campo (CBMMT, 2026).

2.3.2 Seca e déficit hidrológico

O CEMADEN identificou anomalia de precipitação de -277 mm na Bacia do Alto Paraguai no período 2023/2024. Em maio de 2024, 118 municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, considerados conjuntamente, apresentavam pelo menos 40% das áreas agroprodutivas potencialmente afetadas pela seca. O indicador não deve ser interpretado como quantitativo exclusivo de Mato Grosso, mas confirma a natureza regional e persistente da ameaça, com potencial para agravar desabastecimento de água, calor, fumaça, isolamento e pressão assistencial (CEMADEN, 2024).

2.3.3 Emergências epidemiológicas e concentração regional da assistência

Em informe oficial com dados extraídos do SINAN em 14 de fevereiro de 2025, até a Semana Epidemiológica 7, a SES-MT registrou 14 óbitos confirmados por arboviroses: 12 por chikungunya e dois por dengue, todos com confirmação laboratorial. Havia ainda três óbitos por chikungunya e cinco por dengue em investigação. Os óbitos confirmados por chikungunya concentravam-se na Baixada Cuiabana, Sul e Teles Pires; todos ocorreram em pessoas com 50 anos ou mais. As notificações e internações concentradas em municípios de referência, como Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Cáceres, evidenciam deslocamento assistencial e dependência da rede secundária e terciária (SES-MT, 2025).

2.3.4 Relação entre evidência e desenho da contratação

Evidência estadual	Resultado documentado	Consequência para a UHMR	Situação
Escala territorial	142 municípios, 16 Regiões de Saúde e população estimada de 3,95 milhões.	Rotas rodoviárias reais, comunicação satelital, autonomia inicial e ativação regional.	Fonte oficial incorporada
Incêndios florestais 2025	10.968 focos, 3.582 ocorrências e até 72 instrumentos temporários de resposta.	Módulos móveis, suporte respiratório, climatização, energia, logística e operação fora de grandes centros.	Fonte oficial incorporada
Operação de grande extensão	Evento documentado com cerca de 45 mil hectares e múltiplos meios terrestres e aéreos.	Apoio prolongado, rastreabilidade de cargas, manutenção e comunicação redundante.	Fonte oficial incorporada
Seca no Pantanal	Déficit de 277 mm na Bacia do Alto Paraguai em 2023/2024.	WASH, reservação, tratamento de água, controle térmico e plano de reabastecimento.	Fonte oficial incorporada

Evidência estadual	Resultado documentado	Consequência para a UHMR	Situação
Arboviroses 2025	14 óbitos confirmados até a SE 7 e concentração do atendimento em polos regionais.	N1/N2 para triagem, hidratação e observação; N3 quando houver internação, casos críticos e necessidade diagnóstica.	Fonte oficial incorporada
Capacidade hospitalar	Leitos operacionais, bloqueios e ocupação ainda dependem de extração padronizada.	Definição dos gatilhos N1-N4 e dimensionamento regional.	Validar em CNES, IndicaSUS e Monitora Hospitalar
Pressão regulatória	Filas, tempos e transferências ainda dependem de base anonimizada.	Localização, pré-posicionamento e prioridade de acionamento.	Validar no SISREG
Histórico de eventos	Frequência, duração, recursos e lacunas ainda serão auditados.	Estimativa de acionamentos e cenário de consumo para preços.	Validar no CIEVS-MT e S2iD

Os dados públicos acima sustentam a necessidade qualitativa e parte do desenho funcional. O dimensionamento definitivo e a estimativa de frequência de acionamento permanecem condicionados à consolidação das bases internas descritas no Anexo F.

3. Objetivos da contratação

3.1 Objetivo geral

Disponibilizar capacidade estadual permanente de prontidão para implantação e operação de unidade hospitalar temporária modular, segura e escalonável, integrada ao SUS e apta a apoiar ou substituir parcialmente serviços de saúde afetados por emergências.

3.2 Objetivos específicos

- iniciar atendimento essencial em configuração N1 no menor prazo tecnicamente viável;
- implantar configuração hospitalar N3 em até 24 horas após chegada da carga a sítio liberado e apto, como meta a validar em consulta ao mercado;
- escalar ou reduzir módulos sem interromper a assistência;
- garantir redundância dos sistemas críticos e autonomia inicial mínima de 72 horas;
- assegurar comunicação por satélite, rede móvel e rádio, com contingência;
- integrar triagem, regulação, vigilância, prontuário, diagnóstico, farmácia e logística;
- manter inventário, manutenção, calibração, treinamento e simulações durante a prontidão;
- estabelecer medição por resultados, níveis de serviço e evidências verificáveis.

4. Alinhamento institucional e normativo

A demanda deverá ser vinculada ao planejamento estratégico, ao Plano de Contratações Anual e aos instrumentos orçamentários da SES-MT. Caso ainda não esteja prevista no PCA, a área requisitante deverá justificar a inclusão superveniente e demonstrar disponibilidade orçamentária conforme o rito estadual.

Referência	Aplicação ao planejamento
Lei Federal nº 14.133/2021	Planejamento da contratação, ETP, Termo de Referência, parcelamento, prova de conceito, matriz de riscos, gestão e fiscalização.
Decreto Estadual nº 1.525/2022 e normas estaduais correlatas	Regulamentação da Lei nº 14.133/2021 no Poder Executivo de Mato Grosso e procedimentos do SIAG.
Lei nº 13.709/2018 - LGPD	Tratamento de dados pessoais e dados de saúde, segurança, controle de acesso e resposta a incidentes.
RDC Anvisa nº 50/2002	Referência físico-funcional para estabelecimentos assistenciais, adaptada à natureza temporária e modular.
RDC Anvisa nº 63/2011	Boas práticas de funcionamento, recursos, infraestrutura e qualidade dos serviços de saúde.
RDC Anvisa nº 36/2013	Ações de segurança do paciente em serviços de saúde.
RDC Anvisa nº 222/2018	Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, inclusive em estruturas móveis/temporárias.
NR-10, NR-23 e NR-32	Segurança em eletricidade, proteção contra incêndios e segurança e saúde em serviços de saúde.
OMS - Blue Book EMT, 2021	Classificação e padrões mínimos para equipes médicas de emergência; referência funcional para N3.
Consulta Pública FNSUS nº 04/2026	Benchmark nacional recente para hospital de campanha modular EMT Tipo 2, testes, logística e consulta ao mercado.
IBGE - estimativa populacional 2026 e área territorial	Caracterização da população, escala territorial e dispersão geográfica.
SES-MT - organização regional 2026	Abrangência de 142 municípios distribuídos em 16 Regiões de Saúde.
CBMMT - Relatório Final da Temporada de Incêndios Florestais 2025	Evidência de operações extensas, temporárias, descentralizadas e de difícil acesso.
CEMADEN - Nota Técnica do Pantanal 2024	Evidência de seca prolongada e déficit hidrológico na Bacia do Alto Paraguai.
SES-MT - Perfil dos óbitos por dengue e chikungunya 2025	Evidência de gravidade, concentração regional da assistência e necessidade de expansão temporária.

As normas técnicas específicas de instalações elétricas, gases medicinais, climatização, proteção contra incêndio, radiologia, acessibilidade, engenharia clínica e telecomunicações deverão ser confirmadas pelas áreas competentes na elaboração do Termo de Referência, adotando-se sempre suas versões vigentes. A simples menção a uma norma não dispensa a definição do desempenho esperado e do método de comprovação.

5. Cenários de emprego e estimativa da demanda

5.1 Cenários prioritários

Cenário	Lacuna provável	Resposta modular
Enchentes, incêndios florestais, seca extrema e eventos climáticos	Isolamento territorial, perda de unidade, demanda respiratória/trauma, falha de energia ou água.	N1/N2 para reforço; N3/N4 quando houver perda de capacidade hospitalar.
Surto, epidemia ou ameaça biológica	Aumento rápido de demanda, necessidade de separação de fluxos e isolamento.	N1 de triagem; N2 assistencial; N3 com isolamento e internação.
Incidente com múltiplas vítimas	Pico de vítimas, estabilização, cirurgia e evacuação.	N1 imediato; N2/N3 conforme número e gravidade.
Interrupção de hospital	Perda parcial ou total de emergência, internação, centro cirúrgico ou utilidades.	Módulos específicos ou N3; N4 se substituição prolongada.
Desassistência temporária ou acesso remoto	Capacidade local insuficiente e longas distâncias de referência.	N1/N2, com telemedicina e diagnóstico portátil.
Grande evento	Demanda concentrada e necessidade de retaguarda temporária.	N1/N2 pré-posicionado.

5.2 Variáveis para escolha do nível

- número estimado de pacientes por dia, vítimas críticas e necessidade de internação;
- capacidade residual e tempo de recuperação da rede local;
- necessidade de cirurgia, cuidados intensivos, isolamento, pediatria ou obstetrícia;
- duração projetada da operação e possibilidade de reabastecimento;
- distância, condição dos acessos, segurança e riscos do sítio;
- disponibilidade de energia, água, saneamento, comunicações e destino de resíduos;
- necessidade de evacuação, regulação e integração com hospitais de referência.

5.3 Método de dimensionamento

Os quantitativos deverão ser validados com base em cenários históricos estaduais, capacidade instalada, vazios assistenciais, tempos de deslocamento, população exposta e análise de risco. Para cada nível, recomenda-se utilizar as seguintes memórias de cálculo:

Componente	Memória de cálculo recomendada
Atendimento diário	Demanda projetada por 24 h x fator de pico x duração da missão.
Leitos	Entradas/dia x proporção de internação x permanência média, acrescida de reserva técnica.
Posições críticas	Chegadas críticas por hora x tempo médio de estabilização x fator de simultaneidade.
Oxigênio	Número de pacientes por modalidade x fluxo médio x horas de uso x fator de segurança.
Água	Pacientes + trabalhadores x consumo por pessoa/dia + processos clínicos e limpeza.

Componente	Memória de cálculo recomendada
Energia	Somatório de cargas simultâneas x fator de demanda + partida de motores + reserva N+1.
Medicamentos e insumos	Protocolos assistenciais x casuística estimada x dias de autonomia + estoque de segurança.
Equipes	Postos de trabalho por turno x cobertura 24/7 x descanso e reserva operacional.

6. Requisitos da contratação

6.1 Requisitos funcionais mínimos

- ativação parcial e independente dos módulos, com interfaces padronizadas;
- transporte, descarga, instalação, comissionamento, operação, manutenção e desmobilização door-to-field;
- layout com fluxos de pacientes, trabalhadores, materiais limpos, resíduos e ambulâncias;
- piso rígido, lavável, antiderrapante, acessível, nivelável e compatível com macas e equipamentos;
- proteção climática, ancoragem, estanqueidade, isolamento térmico e controle de pragas;
- sistemas críticos redundantes, peças sobressalentes e contingência documentada;
- capacidade de expansão sem fechamento da unidade;
- registro digital de inventário, manutenção, consumo, lote, validade, ocorrências e desempenho.

6.2 Requisitos clínicos e de apoio

Domínio	Requisito
Triagem e recepção	Cadastro, classificação de risco, identificação, espera protegida e fluxos separados quando indicados.
Emergência	Sala de estabilização com monitorização, ventilação, desfibrilação, aspiração, infusão e procedimentos.
Internação	Leitos modularizados, privacidade, oxigênio, pontos elétricos e posto de enfermagem.
Cirurgia	Sala cirúrgica, anestesia, recuperação pós-anestésica, controle ambiental e esterilização.
Isolamento	Ambientes independentes; quando houver transmissão aérea, pressão negativa, monitorização, alarmes, exaustão/filtragem e contingência.
Diagnóstico	Laboratório point-of-care, ultrassom portátil, radiografia digital móvel e integração de resultados.
Farmácia	Armazenamento seguro, cadeia fria, rastreabilidade, dispensação e controle de medicamentos sujeitos a controle especial.
WASH	Água segura, reservação, distribuição, lavatórios, sanitários, chuveiros, drenagem, efluentes e controle de qualidade.

Domínio	Requisito
Resíduos	PGRSS operacional, segregação, acondicionamento, abrigo, transporte, tratamento/destinação e contingência.

6.3 Energia, gases e climatização

- arquitetura N+1 para cargas críticas, com rede quando disponível, geradores, transferência e UPS/baterias;
- autonomia inicial mínima de 72 horas, incluído combustível, e plano de reabastecimento contínuo;
- aterramento, proteção contra surtos, seletividade, monitoramento de carga e diagramas atualizados;
- oxigênio medicinal, aspiração/vácuo e, quando requerido, ar comprimido medicinal, com fonte principal e reserva;
- cálculos de consumo e capacidade para pico assistencial, com alarmes e plano de contingência;
- HVAC dimensionado para o clima de Mato Grosso e para as cargas internas, com controle diferenciado em áreas críticas.

6.4 Requisitos de qualidade e comprovação

- registro e regularização dos produtos e equipamentos perante autoridades competentes, quando aplicável;
- responsabilidade técnica e Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica pertinentes;
- laudos, certificados ou ensaios de desempenho emitidos por entidades competentes ou acreditadas;
- calibração rastreável de equipamentos e instrumentos;
- manuais em português, plano de manutenção, lista de sobressalentes e treinamento;
- FAT, SAT, prova de conceito e testes de aceitação integrados;
- não direcionamento a marca, admitindo solução equivalente que comprove desempenho.

7. Levantamento de mercado e análise de alternativas

O levantamento de mercado deverá consultar fabricantes, integradores, operadores hospitalares, empresas de logística, engenharia clínica, telecomunicações e prestadores assistenciais. Recomenda-se consulta pública ou Request for Information - RFI antes do Termo de Referência, utilizando como referência metodológica a Consulta Pública FNSUS nº 04/2026.

Alternativa	Vantagens	Limitações/riscos	Avaliação
Aquisição integral pelo Estado	Patrimônio próprio e disponibilidade exclusiva.	Alto investimento inicial; armazenamento, obsolescência, manutenção, pessoal e baixa utilização.	Manter como comparador de custo total do ciclo de vida.
Locação somente após o evento	Sem mensalidade de prontidão.	Disponibilidade incerta, preço emergencial, prazos longos e solução não testada previamente.	Não recomendada como estratégia principal.

Alternativa	Vantagens	Limitações/riscos	Avaliação
Serviço integrado de prontidão e acionamento	Disponibilidade contratada, manutenção contínua, SLA, modularidade e previsibilidade.	Exige modelagem cuidadosa, fiscalização e prova de capacidade.	Alternativa preferencial.
Contratos separados por sistema	Maior concorrência por especialidade.	Alto risco de interface, comando fragmentado e testes integrados complexos.	Usar apenas em lotes funcionalmente integráveis.
Cooperação sem contratação	Menor custo fixo direto.	Sem garantia de capacidade, prazo ou exclusividade.	Complementar, nunca substitutiva.
Locação estrutural sem integração	Reduz aquisição patrimonial e permite contratar a estrutura física.	Mantém sob a SES interfaces de logística, energia, TI, equipamentos e comissionamento; risco de dessincronização.	Comparador; não recomendada isoladamente.
Expansão exclusiva da rede fixa	Amplia capacidade permanente e fortalece a regionalização.	Não atende perda súbita de unidades, isolamento territorial ou picos transitórios; longo prazo de implantação.	Complementar e necessária, mas não substitutiva.

7.1 Recomendação da alternativa

Alternativa mais vantajosa para aprofundamento

Serviço continuado de prontidão e resposta, com infraestrutura e logística integradas, capacidade N3 como referência de planejamento e módulos ou itens precificados separadamente. A decisão final dependerá da comparação do custo total entre aquisição e serviço, da capacidade do mercado e da aderência ao contrato hospitalar no qual a obrigação poderá ser inserida.

8. Solução recomendada

A solução será composta por núcleo físico e tecnológico modular, armazenado e mantido em prontidão, com cadeia logística dedicada, equipe de montagem e suporte, sistemas clínicos e utilidades, suprimentos iniciais e possibilidade de ativação de equipes assistenciais. A contratada integradora responderá pelo desempenho conjunto e pela compatibilidade dos subsistemas sob sua responsabilidade.

8.1 Descrição do objeto sugerida

Redação-base

Contratação de solução integrada, modular, escalável e mobilizável para disponibilidade, transporte, implantação, comissionamento, operação, manutenção e desmobilização de Unidade Hospitalar Modular de Resposta a Emergências - UHMR, compreendendo infraestrutura temporária, equipamentos médico-hospitalares, mobiliário, energia, climatização, gases medicinais, água e saneamento, telecomunicações, tecnologia da informação, conectividade satelital, insumos, apoio logístico e operacional e, quando acionado, equipes profissionais, destinada ao atendimento de emergências em saúde pública, desastres, incidentes com múltiplas vítimas, interrupção de serviços e desassistência.

8.2 Limites de escopo

Incluído	A definir/contratação correlata
Prontidão, armazenagem, inventário, manutenção e testes.	Segurança pública externa e controle territorial do perímetro.
Transporte, montagem, comissionamento e desmontagem.	Obras permanentes e recuperação definitiva do estabelecimento afetado.
Utilidades, conectividade, equipamentos e suporte técnico.	Remoção aeromédica e transporte sanitário além do perímetro, salvo módulo específico.
Consumíveis iniciais e reposição conforme pacote contratado.	Fornecimento de sangue e hemocomponentes, conforme hemorrede e protocolos.
Equipe operacional e, se acionado, módulo assistencial.	Atribuições indelegáveis de autoridade sanitária, regulação e comando estadual.

9. Arquitetura modular e níveis de ativação

Nível	Situação de uso	Capacidade indicativa	Meta de implantação*
N0 - Prontidão	Sem missão ativa.	Armazenagem, manutenção, estoque, testes e exercícios.	Permanente
N1 - Resposta rápida	Evento localizado, múltiplas vítimas ou interrupção parcial.	Triagem; 2-4 posições críticas; 6-12 observação; procedimentos; POC.	6-12 h
N2 - Assistência ampliada	Sobrecarga municipal/regional ou missão de alguns dias.	Referência: 12-20 leitos/observação, 4 críticos, diagnóstico e farmácia, selecionáveis conforme missão.	Até 18 h
N3 - Hospital modular	Perda hospitalar, desastre regional ou epidemia.	Mín. 20 leitos, expansível a 30; 4 críticos; 1 centro cirúrgico; isolamento; CME; imagem.	Até 24 h
N4 - Hospital expandido	Catástrofe ou substituição prolongada.	40-100 leitos; UTI modular; 2º centro cirúrgico; especialidades e apoio ampliado.	36-48 h

* Metas contadas conforme marcos contratuais definidos no item 13 e sujeitas à validação por consulta ao mercado. O prazo de transporte deve ser medido separadamente do prazo de montagem.

9.1 Princípios de configuração

- os níveis são referenciais e permitem módulos isolados ou combinados, sem ativação cumulativa obrigatória;
- a ampliação não pode exigir interrupção dos módulos já operacionais;
- leitos críticos devem ser contabilizados separadamente dos leitos de enfermaria;
- o N3 deve manter compatibilidade funcional com EMT Tipo 2, sem exigir automaticamente certificação OMS da licitante;
- o N4 deve ser tratado como expansão opcional, evitando custo fixo desproporcional;
- o layout final deve ser aprovado após Site Assessment e incluir rotas de ambulância, evacuação e segurança.

10. Ciclo operacional e logística

10.1 Prontidão

Durante N0, a contratada deverá manter a solução completa, identificada, rastreável, testada e disponível, com equipe de acionamento, planos atualizados, estoque dentro da validade e registros auditáveis. A SES-MT poderá inspecionar o local de armazenagem e solicitar testes sem aviso prévio, dentro de regras definidas.

10.2 Acionamento e reconhecimento

1. Emissão da Ordem de Acionamento e definição preliminar do nível.
2. Confirmação, ativação do ponto focal e reunião inicial.
3. Avaliação remota e/ou presencial do sítio, acessos, ameaças e utilidades.
4. Plano de Mobilização com rota, cargas, equipe, cronograma, necessidades e riscos.
5. Liberação do sítio pela Administração e início do deslocamento.
6. Montagem, integração, testes, comissionamento e Termo de Liberação Operacional.
7. Operação, expansão/redução e reabastecimento.
8. Desmobilização, descontaminação, inventário, reposição e relatório pós-ação.

10.3 Site Assessment mínimo

Domínio	Verificações
Terreno e ameaças	Coordenadas, área útil, declividade, drenagem, inundação, vento, incêndio, estruturas próximas e segurança.
Acesso e fluxo	Rodovias, pontes, restrições de peso/altura, área de manobra, ambulâncias, pedestres, evacuação e pouso quando aplicável.
Utilidades	Energia, água, esgoto, resíduos, combustível, iluminação e pontos de conexão.
Rede assistencial	Unidades de referência, regulação, SAMU, laboratório, hemorrede, farmácia e transporte sanitário.

Domínio	Verificações
Comunicações	Cobertura móvel, visada/installação satelital, rádio, interferências e segurança da informação.
Licenciamento	Autorizações locais, vigilância sanitária, incêndio, radiologia, meio ambiente e ocupação do sítio.

10.4 Transporte e rastreabilidade

- embalagens e cases resistentes, identificados por módulo, caixa, peso, volume, conteúdo e prioridade de descarga;
- QR Code ou RFID, manifesto eletrônico de carga e cadeia de custódia;
- plano rodoviário para todas as regiões de Mato Grosso, com rotas alternativas;
- meios próprios ou contratos firmes para veículos, empilhadeiras, guindastes e apoio local;
- compatibilidade com aerotransporte civil como requisito desejável; paletização militar apenas se justificada.

10.5 Desmobilização

A desmobilização dependerá de autorização da SES-MT e de plano que assegure suspensão ordenada de admissões, transferência de pacientes, encerramento de registros, inventário, descontaminação, resíduos, desmontagem, transporte, manutenção pós-missão, reposição e retorno à prontidão. Em até 15 dias úteis, a contratada deverá apresentar Relatório Pós-Ação, salvo prazo menor definido pela gravidade do evento.

11. Comunicações, tecnologia e proteção de dados

11.1 Arquitetura de conectividade

Camada	Requisito mínimo
Satélite	Terminal de rápida instalação, plano de dados compatível com operação clínica, energia protegida e redundância de equipamentos críticos.
Rede móvel	Roteador multi-SIM com pelo menos duas operadoras quando houver cobertura e failover automático.
Rádio	Comunicação operacional interna e interoperabilidade planejada com SAMU, Defesa Civil, segurança e logística.
Rede local	Wi-Fi corporativo e cabeado; segmentação clínica, administrativa, dispositivos e convidados; firewall e VPN.
Telefonia/telemedicina	Telefonia IP, videoconferência e recursos para teleconsultoria e apoio diagnóstico.

11.2 Sistemas de informação

- registro de atendimento e prontuário com modo offline e sincronização controlada;
- identificação do paciente, classificação de risco, prescrição, administração, exames, alta e transferência;
- integração com regulação, vigilância, CNES e sistemas definidos pela SES-MT;

- painel operacional de leitos, filas, estoque, consumo, equipe, energia, água, gases e incidentes;
- exportação de dados em formatos abertos e entrega integral à SES-MT ao fim da missão;
- trilhas de auditoria, perfis de acesso, autenticação forte, criptografia, backup e resposta a incidentes;
- proibição de uso secundário dos dados pela contratada sem base legal e autorização expressa.

11.3 Continuidade digital

O Termo de Referência deverá definir RTO e RPO dos sistemas, procedimentos manuais de contingência, tempo máximo de indisponibilidade, capacidade offline, rotina de backups e testes de restauração. A comunicação principal ou redundante deverá possuir disponibilidade mensal compatível com missão crítica, com exclusões objetivas e evidências de medição.

12. Equipes e organização do trabalho

A composição exata das equipes dependerá do perfil assistencial e das normas profissionais vigentes. Recomenda-se separar o núcleo operacional permanente das equipes clínicas acionáveis, permitindo ao Estado mobilizar profissionais próprios, contratar módulo assistencial ou combinar ambos.

Núcleo	Perfis indicativos
Comando	Coordenador da missão; direção clínica; coordenação de enfermagem; operações/logística; administração; segurança; ligação com SES/COES.
Assistencial	Emergencistas/clínicos; cirurgião; anestesiolologista; pediatra; intensivista quando aplicável; enfermeiros; técnicos; fisioterapeuta; farmacêutico; psicólogo; assistente social.
Diagnóstico	Profissionais de laboratório, radiologia e ultrassonografia, conforme escopo.
Técnico-operacional	Engenharia clínica; elétrica; mecânica; HVAC; gases; TI; telecom; WASH; logística; limpeza; alimentação; segurança patrimonial.
Reserva	Profissionais e operadores para substituição, descanso, afastamentos e expansão.

12.1 Regras de dimensionamento

- matriz por posto de trabalho, turno, nível e capacidade assistencial;
- cobertura 24/7 com limites de jornada, descanso, alojamento e alimentação;
- credenciamento, registro profissional, vacinação, saúde ocupacional e treinamento;
- competências para emergência, trauma, controle de infecção, segurança e trabalho em campo;
- integração ao comando da missão e protocolos da SES-MT;
- responsabilidade clínica da SES-MT preservada nos termos definidos pela autoridade sanitária.

13. Modelo de execução e níveis de serviço

13.1 Marcos do acionamento

Marco	Prazo indicativo	Evidência
T0 - Ordem de Acionamento	Imediato	Documento assinado/registro no sistema.
Confirmação de recebimento	Até 15 min	Protocolo e identificação do ponto focal.
Contato operacional	Até 30 min	Registro da conferência inicial.
Plano de Mobilização	Até 2 h	Plano com cargas, equipe, rota, cronograma e riscos.
Primeiros recursos em deslocamento	Até 6 h	Telemetria, manifesto e comprovante de saída.
N1 operacional	6-12 h após chegada/liberação	Termo de Liberação Operacional parcial.
N3 operacional	Até 24 h após chegada/liberação	Termo de Liberação Operacional completo.

Regra de medição do prazo

O contrato deverá manter quatro relógios separados: mobilização, viagem, montagem e comissionamento. Impedimentos atribuíveis à Administração ou a eventos extraordinários somente suspenderão o relógio afetado, mediante registro contemporâneo e validação do fiscal.

13.2 Indicadores contratuais

Indicador	Meta inicial	Medição
Disponibilidade em prontidão	$\geq 99\%$	Checklist mensal e auditorias.
Confirmação do acionamento	≤ 15 min	Registro automático.
Plano de Mobilização	≤ 2 h	Protocolo de entrega.
Equipamentos críticos funcionais	100%	Teste e inventário.
Insumos dentro da validade	100%	Rastreabilidade por lote/validade.
Energia de cargas críticas	$\geq 99,9\%$ na missão	Telemetria e diário operacional.
Comunicação principal ou redundante	$\geq 99\%$ na missão	Logs dos enlaces.
Rastreabilidade patrimonial	100%	Inventário eletrônico.
Não conformidade crítica sem resposta	0	Registro e plano de ação.

13.3 Testes e aceitação

- FAT para subsistemas críticos e integração antes da entrega inicial;
- SAT no local de aceitação, com montagem e operação completas;

- prova de conceito do licitante provisoriamente vencedor, se juridicamente adotada e prevista no edital;
- teste de energia principal, geradores, transferência, UPS, aterramento e cargas;
- teste de climatização, pressão negativa, trocas de ar, alarmes e filtros;
- teste de gases medicinais, água, efluentes, equipamentos, satélite, rede, rádio e sistemas;
- simulação assistencial e de falha dos sistemas críticos;
- exercício completo anual e exercícios parciais periódicos.

14. Estimativas de quantidades

As quantidades abaixo constituem envelope inicial para pesquisa de mercado e deverão ser confirmadas pela equipe de planejamento. A contratação deve prever capacidade de referência N3, com módulos independentes, fornecimentos isolados e opções de expansão N4.

Item de capacidade	Quantidade de referência	Observação
Conjunto UHMR N3	1 conjunto	Núcleo de 20 leitos, expansível a 30, mais quatro posições críticas e uma sala cirúrgica.
Configuração N1	1 subconjunto acionável	Deve operar independentemente do restante.
Configuração N2	1 expansão acionável	Acrescenta leitos, diagnóstico e apoio.
Expansão N4	Opção de 20 a 70 leitos adicionais	Contratação por módulos e diária, conforme evento.
Isolamento respiratório	Mínimo 2 leitos independentes	Pressão negativa quando indicada.
Conectividade satelital	2 terminais ou solução equivalente	Principal e reserva/uso distribuído.
Geradores	Arquitetura N+1	Dimensionados por estudo de carga, não por potência arbitrária.
Autonomia inicial	72 horas	Inclui água, combustível, gases, insumos e consumíveis críticos.
Exercício completo	1 por ano	Montagem, comissionamento e simulação.
Exercícios parciais	Mínimo 2 por ano	Comunicações, energia, inventário e módulos prioritários.

14.1 Estimativa de acionamentos para precificação

Para tornar comparáveis as propostas, a planilha de pesquisa de preços deverá adotar um cenário de consumo estimado sem gerar obrigação de acionamento. Sugestão para simulação econômica: 12 meses de prontidão; um exercício completo anual; duas mobilizações N1 por ano; uma mobilização N2 a cada dois anos; uma mobilização N3 a cada três anos; e N4 apenas como opção. Esses volumes são parâmetros de comparação e devem ser revistos com dados históricos e análise de risco.

15. Parcelamento e estratégia de contratação

O parcelamento deve ser avaliado à luz da competitividade, especialização do mercado e risco de interface. A fragmentação indiscriminada pode comprometer o comissionamento e dificultar a atribuição de responsabilidade quando sistemas críticos falharem em conjunto.

Bloco funcional	Estratégia sugerida
Infraestrutura, utilidades, equipamentos, TI e logística	Lote integrado ou responsabilidade de um integrador líder, com subcontratações qualificadas e responsabilidade única pelo desempenho.
Equipes assistenciais	Módulo/lote separável ou obrigação específica do contrato hospitalar, após validação jurídica e de dimensionamento.
Medicamentos e consumíveis	Kits por perfil e período, ou por item isolado; admitir fornecimento pela SES-MT quando vantajoso, com interface e reposição claramente definidas.
Transporte especial/aéreo	Item sob demanda, sem exigir capacidade militar como requisito de habilitação.

15.1 Consórcios e subcontratação

A participação em consórcio deve ser considerada caso o levantamento de mercado demonstre concentração de capacidades em empresas distintas. A subcontratação poderá ser admitida para especialidades, sem afastar a responsabilidade integral da contratada líder, vedada a subcontratação total do objeto. Requisitos técnicos devem ser proporcionais às parcelas de maior relevância e valor significativo.

16. Resultados pretendidos

Resultado	Indicador de sucesso
Redução do tempo de resposta	Capacidade N1 e N3 instalada nos prazos definidos.
Continuidade assistencial	Operação segura mesmo com falha de uma fonte crítica.
Adequação da capacidade ao evento	Ativação e desativação modular sem interrupção.
Previsibilidade financeira	Preços unitários por prontidão, acionamento, diária e expansão.
Qualidade e segurança	Testes de aceitação aprovados e ausência de não conformidade crítica aberta.
Rastreabilidade	Inventário, consumo, validade, manutenção e incidentes registrados.
Integração ao SUS	Fluxos pactuados com regulação, vigilância, SAMU, rede hospitalar e laboratório.
Aprendizado institucional	Exercícios, AAR e planos de melhoria concluídos.

17. Modelo econômico e pesquisa de preços

A estimativa do valor da contratação somente poderá ser concluída após pesquisa de mercado, consulta a fornecedores e definição do envelope de quantidades. O processo deve registrar preços unitários, memórias de cálculo, fontes, data-base, tributos, mobilização, distâncias, pessoal, manutenção e custo do ciclo de vida.

Componente de preço	Unidade de medição
A. Prontidão	R\$/mês
B. Mobilização	R\$/acionamento por configuração
C. Transporte	R\$/faixa de distância, km ou região
D. Instalação e comissionamento	R\$/nível
E. Operação	R\$/dia por módulo acionado
F. Equipe assistencial	R\$/pacote de 24 h por configuração
G. Consumíveis	R\$/kit/dia ou por perfil
H. Módulo de expansão	R\$/módulo/dia
I. Desmobilização	R\$/evento
J. Treinamento/exercício	R\$/evento

17.1 Comparação de custo total

A análise deverá comparar, em horizonte plurianual, pelo menos: aquisição integral; serviço de prontidão; e locação episódica. Incluir aquisição/locação, depreciação, armazenamento, seguro, manutenção, calibração, licenças, conectividade, atualização tecnológica, equipe de prontidão, exercícios, mobilizações, consumíveis, descarte e valor residual.

18. Providências prévias à contratação

1. Designar formalmente equipe multidisciplinar de planejamento.
2. Definir unidade requisitante, gestor do futuro contrato e fonte orçamentária.
3. Validar cenários e dimensionamento com atenção hospitalar, urgência e emergência, regulação, vigilância, engenharia, STI, assistência farmacêutica, LACEN e áreas administrativas.
4. Extrair, padronizar e validar as séries do CIEVS-MT, CNES, IndicaSUS/Monitora Hospitalar, SISREG, S2iD/Defesa Civil, SIH/SUS, SIA/SUS, SINAN, SIVEP-Gripe e GAL, com dicionário, data de corte e nota metodológica.
5. Promover RFI/consulta pública e visitas técnicas a soluções existentes.
6. Comparar aquisição, locação e serviço pelo custo total do ciclo de vida.
7. Definir parcelamento, participação em consórcio, subcontratação e qualificação técnica.
8. Elaborar matriz de riscos, orçamento estimado, Termo de Referência, minuta contratual e anexos.

9. Submeter os documentos à vigilância sanitária, controle de infecção, engenharia, segurança do trabalho, proteção de dados, aquisições e assessoria jurídica.
10. Planejar governança, treinamento, fiscalização, sistemas de registro e exercícios antes do início da vigência.
11. Mapear e avaliar previamente sítios de instalação nas 16 sedes regionais e em municípios de maior risco, registrando área útil, acesso de cargas, drenagem, segurança, energia, água, esgoto, comunicações e possibilidade de expansão.

18.1 Equipe mínima de planejamento

Área	Contribuição
Unidade demandante/gestão hospitalar	Escopo assistencial, integração ao contrato hospitalar e resultados.
Urgência, emergência e regulação	Fluxos, referência, remoção e dimensionamento.
Vigilância/CIEVS/COES	Cenários, níveis de ativação, comando e vigilância em emergências.
Engenharia e manutenção	Estrutura, energia, HVAC, gases, WASH, incêndio e testes.
STI e proteção de dados	Conectividade, sistemas, cibersegurança, LGPD e interoperabilidade.
Vigilância sanitária/CCIH	Requisitos sanitários, isolamento, fluxos, limpeza e resíduos.
Assistência farmacêutica/LACEN	Medicamentos, cadeia fria, diagnóstico, POC e suprimentos.
Aquisições/orçamento/jurídico	Modelo econômico, licitação, riscos, garantias e minuta.

19. Contratações correlatas e interdependentes

Dependência	Tratamento recomendado
Contrato da unidade hospitalar	Definir se a UHMR será obrigação do mesmo contratado ou contratação autônoma; evitar dupla remuneração.
SAMU e transporte sanitário	Pactuar ambulâncias, remoções, comunicação e prioridade.
Regulação	Integrar acesso, leitos, transferências e referência.
Hemorrede	Definir fornecimento, transporte, cadeia fria e responsabilidade transfusional.
Resíduos e efluentes	Confirmar capacidade local e contingência contratada.
Combustível	Definir inclusão no preço, estoque, segurança e reabastecimento.
Segurança e perímetro	Articular forças estaduais/municipais e segurança patrimonial interna.
Telecomunicações	Licenças, frequências, planos de dados e interoperabilidade.
Licenças sanitárias e locais	Matriz de responsabilidades e rito acelerado para emergência.

20. Sustentabilidade e impactos ambientais

- equipamentos energeticamente eficientes e monitoramento de consumo;
- geradores com controle de emissões, ruído, contenção de combustível e manutenção;
- redução de descartáveis quando clinicamente segura e sem comprometer o controle de infecção;
- segregação e destinação de resíduos conforme PGRSS e licenças;
- uso racional de água, detecção de vazamentos e solução adequada de efluentes;
- embalagens reutilizáveis, inventário de químicos e logística reversa quando aplicável;
- recuperação do sítio após desmobilização e registro de passivos ambientais;
- critérios sociais e trabalhistas, acessibilidade e condições dignas para pacientes e equipes.

21. Riscos preliminares

Risco	Prob.	Impacto	Tratamento/alocação inicial
Atraso na mobilização	Média	Alto	SLA, rastreamento, rotas alternativas, penalidade; contratada.
Sítio inadequado ou não liberado	Média	Alto	Site Assessment e locais pré-mapeados; Administração/compartilhado.
Falha de energia ou combustível	Média	Crítico	N+1, UPS, telemetria e estoque; contratada conforme escopo.
Falha de gases medicinais	Baixa	Crítico	Fonte reserva, cálculo de consumo, alarmes e reposição; contratada.
Incompatibilidade entre subsistemas	Média	Crítico	Integrador único, FAT/SAT e prova de conceito; contratada.
Falta de profissionais	Média	Crítico	Reserva, escala e substituição; responsável pelo módulo assistencial.
Ruptura de estoque/validade	Média	Alto	FEFO, rastreabilidade, kits e estoque de segurança; contratada/SES conforme matriz.
Indisponibilidade de comunicação	Alta	Alto	Satélite + móvel + rádio; contratada.
Evento acima do envelope de projeto	Baixa	Crítico	Limites declarados, evacuação e matriz contratual; compartilhado.
Incidente de dados	Média	Alto	Segurança, logs, criptografia e resposta; alocação conforme causa.
Restrição competitiva	Média	Alto	RFI, requisitos funcionais, equivalência e qualificação proporcional; Administração.
Custo fixo desproporcional	Média	Alto	Modelo por prontidão + acionamento e expansão opcional; Administração.

A matriz definitiva deverá atribuir proprietário, causa, consequência, controles preventivos, plano de contingência, gatilhos, evidências e impacto econômico, vinculando riscos às cláusulas contratuais e ao equilíbrio econômico-financeiro.

22. Governança, fiscalização e medição

22.1 Governança da missão

Nível	Responsabilidade
Estratégico - SES/COE/COES	Definir missão, nível, prioridades, articulação interinstitucional, comunicação pública e encerramento.
Coordenação da missão	Comando unificado, ligação com território, segurança, regulação e acompanhamento dos resultados.
Direção clínica	Protocolos assistenciais, segurança do paciente, escalas, referência e qualidade clínica.
Operações e logística	Infraestrutura, utilidades, estoque, transporte, manutenção e continuidade.
Vigilância e informação	Notificação, análise, situação epidemiológica, dados, indicadores e comunicação de risco.

22.2 Fiscalização contratual

- gestor do contrato e fiscais técnico, administrativo e setoriais formalmente designados;
- painel com SLA, disponibilidade, chamados, inventário, manutenção, consumo e não conformidades;
- boletim diário durante missão e relatório mensal na prontidão;
- medição vinculada a entregas e resultados, com glosas objetivas e direito de contraditório;
- reuniões de desempenho, auditorias, inspeções, exercícios e planos de melhoria;
- registro de decisões, mudanças de escopo e eventos de risco.

23. Conclusão de viabilidade

A contratação é tecnicamente necessária e potencialmente viável, pois responde a risco relevante de interrupção ou insuficiência temporária da rede e pode reduzir o tempo de expansão assistencial em emergências. A arquitetura modular por níveis permite compatibilizar capacidade e custo, enquanto o modelo de prontidão e acionamento evita depender exclusivamente de contratações emergenciais posteriores ao evento.

A viabilidade definitiva fica condicionada à confirmação da demanda, consulta ao mercado, comparação entre aquisição e serviço pelo custo total do ciclo de vida, pesquisa de preços, validação sanitária e de engenharia, definição do tratamento das equipes assistenciais, disponibilidade orçamentária e análise jurídica. Recomenda-se prosseguir para RFI/consulta pública e elaboração do Termo de Referência com anexos técnicos.

Declaração preliminar

Com base nas informações disponíveis, a solução é considerada viável para prosseguimento do planejamento, com recomendação do modelo híbrido de capacidade integrada, modular e acionável. Esta conclusão não autoriza a contratação antes do cumprimento das etapas preparatórias.

24. Deliberações necessárias

Decisão	Opções a validar	Área responsável
Inserção no contrato hospitalar ou contratação autônoma	Obrigação do operador hospitalar / licitação específica / modelo combinado.	Gestão hospitalar, aquisições e jurídico.
Base logística	Na unidade contratada / região metropolitana / base regional.	Logística e gestão.
Equipe assistencial	SES / contratada / módulo híbrido.	Atenção hospitalar, RH e jurídico.
Capacidade N3	20, 24 ou 30 leitos, preservando mínimo EMT Tipo 2.	Área assistencial.
Expansão N4	40, 60 ou 100 leitos máximos.	Planejamento e orçamento.
Autonomia	72 h inicial e estratégia de 7-14 dias.	Logística e engenharia.
Prazo de implantação	Metas por configuração após consulta ao mercado.	Equipe de planejamento.
Modelo de contratação	Pregão/concorrência, SRP quando cabível, vigência e garantias.	Aquisições e jurídico.
Prova de conceito	Escopo, local, custos, fase e critérios eliminatórios.	Equipe técnica e aquisições.

Referências

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Consulta Pública nº 04/2026: coleta de informações para formação de preços e requisitos aplicáveis às Emergency Medical Teams. Publicada em 13 ago. 2026; encerrada em 9 set. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2026/coleta-de-informacoes-para-formacao-de-precos-visando-atender-aos-requisitos-tecnicos-e-operacionais-aplicaveis-as-emt>. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011. Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. Ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.

MATO GROSSO. Decreto nº 1.525, de 23 de novembro de 2022. Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito do Poder Executivo Estadual.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029330>. Acesso em: 16 set. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mato Grosso: Cidades e Estados. População estimada em 2026. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt.html>. Acesso em: 16 set. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Resolução CIB/MT Ad Referendum nº 77, de 27 de agosto de 2026. Registra abrangência estadual de 142 municípios distribuídos em 16 Regiões de Saúde. Disponível em: <https://www.saude.mt.gov.br/storage/files/vdu25efI9kwG57OCs00SdXC0r59O0u8UIRmKDQxJ.pdf>. Acesso em: 16 set. 2026.

MATO GROSSO. Corpo de Bombeiros Militar. Relatório Final da Temporada de Incêndios Florestais 2025. Cuiabá: CBMMT, jan. 2026. Disponível em: <https://sema.mt.gov.br/site/phocadownload/CEGF/Temporada%20Incndios%20Florestais%202025%20Relatrio%20Final.pdf>. Acesso em: 16 set. 2026.

BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Nota técnica sobre análise das condições de secas e previsões hidrológicas para a região do Pantanal. 7 jun. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cemaden/pt-br/nota-tecnica-sobre-analise-das-condicoes-de-secas-e-previsoes-hidrologicas-para-a-regiao-do-pananal>. Acesso em: 16 set. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Perfil dos óbitos por dengue e chikungunya em Mato Grosso em 2025. Dados do SINAN extraídos em 14 fev. 2025. Disponível em: <https://www.saude.mt.gov.br/storage/files/GfVSYD5xsAA7vriPLWMGXn0y5kvWaKxQoDIEYFCz.pdf>. Acesso em: 16 set. 2026.

ANEXO A - Matriz resumida de módulos por nível

Módulo	N1	N2	N3	N4
Comando, recepção e triagem	Obrig.	Obrig.	Obrig.	Ampliado
Sala de estabilização	2-4	4	4	4-10
Observação/internação	6-12 obs.	12-20	20-30	40-100
Consultórios	1-2	2-4	4	4+
Centro cirúrgico	-	Opcional	1	1-2
Isolamento	Fluxo separado	1-2	2	2+
POC/laboratório	Básico	Ampliado	Completo	Completo+
Imagem	USG opc.	USG	USG + RX	Ampliada
CME/esterilização	Processo local	Apoio	Obrig.	Ampliada
WASH e resíduos	Essencial	Ampliado	Completo	Completo+
Energia N+1	Cargas críticas	Obrig.	Obrig.	Obrig.
Satélite/móvel/rádio	Obrig.	Obrig.	Obrig.	Obrig.

ANEXO B - Checklist de liberação operacional

Domínio	Critérios mínimos	Situação
Estrutura e fluxo	Ancoragem, piso, acessibilidade, estanqueidade, sinalização, rotas e controle de acesso.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Energia	Rede, geradores, transferência, UPS, aterramento, proteção, carga e combustível.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Climatização/isolamento	Temperatura, pressão, trocas de ar, fluxo, filtros, alarmes e contingência.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Gases	Pureza/documentação, pressão, vazamento, alarmes, fontes e reserva.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Água/efluentes	Qualidade, reservação, vazão, drenagem, sanitários e descarte.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Equipamentos	Inventário, teste funcional, acessórios, calibração, bateria e reserva.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
TI/comunicações	Satélite, móvel, rádio, Wi-Fi, VPN, sistemas, impressoras e modo offline.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Farmácia/insumos	Estoque, lote, validade, cadeia fria, controlados e kits.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Resíduos/limpeza	PGRSS, coletores, abrigo, rota, produtos e equipe.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Pessoas	Escalas, credenciais, EPI, treinamento, alimentação, descanso e saúde ocupacional.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Segurança	Incêndio, iluminação, evacuação, perímetro, incidentes e contatos.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A
Integração SUS	Regulação, SAMU, referência, vigilância, laboratório e comunicação pública.	☐ Conforme ☐ NC ☐ N/A

ANEXO C - Perguntas mínimas para RFI/consulta ao mercado

1. Qual tecnologia construtiva, vida útil, número de ciclos de montagem e condições de armazenamento?
2. Qual peso, volume, número de veículos e sequência de cargas para cada nível?
3. **Qual prazo real de mobilização, viagem, montagem e comissionamento, por configuração?**
4. Quais requisitos de terreno, equipamentos de movimentação e número de montadores?
5. Como se comprova resistência a calor, chuva, vento, fogo, UV e cargas de piso?
6. Como funcionam energia N+1, autonomia, abastecimento, UPS e telemetria?
7. Qual solução de gases medicinais e qual consumo máximo demonstrado?
8. Como se comprova pressão negativa, ACH, filtragem, alarmes e contingência?
9. Qual capacidade de água, efluentes, sanitários, chuveiros e resíduos?
10. Quais equipamentos, registros, calibrações, sobressalentes e assistência no Brasil?
11. Como é fornecida a conectividade satelital e quais SLAs e franquias de dados?
12. A solução opera offline e integra dados por APIs ou formatos abertos?
13. Quais equipes podem ser fornecidas, em quanto tempo e com qual reserva?
14. Quais itens podem ser ativados independentemente e como são precificados?
15. O fornecedor aceita FAT, SAT, prova de conceito e exercícios periódicos?
16. Quais custos de ciclo de vida, manutenção, atualização, seguro e reposição?
17. Quais requisitos podem restringir a competição e quais equivalências são tecnicamente viáveis?

ANEXO D - Estrutura mínima do Termo de Referência

- Objeto e definições; fundamentação e vínculo com o ETP;
- matriz N0-N4 e catálogo de módulos;
- especificações funcionais e métodos de comprovação;
- equipamentos, mobiliário, consumíveis e kits;
- matriz de equipes por configuração e turno;
- logística, base, transporte, Site Assessment e mobilização;
- comissionamento, FAT, SAT e prova de conceito;
- prontidão, manutenção, calibração, treinamento e exercícios;
- SLA, indicadores, relatórios, medição, glosas e sanções;
- modelo econômico e planilha de preços unitários;
- qualificação técnica, consórcio e subcontratação;
- governança, segurança do paciente, LGPD e cibersegurança;
- matriz de riscos, garantias, seguros e continuidade;
- desmobilização, descontaminação, AAR e retorno à prontidão.

ANEXO E - Registro de validações

Área validadora	Nome/função	Data	Parecer/ressalvas
Unidade requisitante			
Atenção hospitalar			
Urgência/regulação			
Vigilância/CIEVS			
Engenharia/manutenção			
Vigilância sanitária/CCIH			
STI/LGPD			
Assistência farmacêutica/LACEN			
Aquisições/orçamento			
Assessoria jurídica			

ANEXO F - Base estadual de evidências

Este anexo estabelece o conjunto mínimo de dados necessário para confirmar o dimensionamento, os gatilhos de ativação, a localização logística, a frequência estimada de missões e o cenário de consumo utilizado na pesquisa de preços. As bases deverão ser entregues com dicionário, responsável, data de extração, período de referência, regras de cálculo e indicação de dado preliminar ou consolidado.

Base	Período e granularidade	Conteúdo mínimo	Finalidade
CIEVS-MT	2019-2026; evento e município	Sinal, detecção, notificação, verificação, resposta, encerramento, casos, óbitos, duração, recursos e ativação de COE/COES.	Frequência de missões, cenários e tempos de resposta.
CNES	Competência atual + série mensal	Estabelecimentos, leitos existentes/SUS, equipamentos, serviços, profissionais e gestão.	Capacidade instalada e vazios assistenciais.
IndicaSUS/Monitora	24-36 meses; diário ou semanal	Leitos elegíveis, operacionais, ocupados, bloqueados, admissões, altas, óbitos e espera no pronto-socorro.	Picos, capacidade residual e gatilhos N1-N4.
SISREG	24-36 meses; solicitação anonimizada	Origem, destino, prioridade, especialidade, leito, solicitação, autorização, transferência, recusa e cancelamento.	Pressão regional, espera e deslocamento assistencial.
S2iD/Defesa Civil	2015-2026; evento e município	COBRADE, decreto, pessoas afetadas, isolamento, danos, serviços essenciais e unidades de saúde atingidas.	Recorrência territorial e impacto de desastres.
Interrupções hospitalares	2021-2026; ocorrência e CNES	Energia, água, oxigênio, incêndio, alagamento, estrutura, TI, setores, leitos perdidos, transferências e duração.	Substituição parcial de unidades e módulos especializados.
SINAN/SIVEP/GAL/SIM/SIH/SIA	2019-2026; município e semana/mês	Casos, exames, hospitalizações, UTI, óbitos, positividade, tempo laboratorial e produção assistencial.	Perfil clínico, sazonalidade e kits assistenciais.

Base	Período e granularidade	Conteúdo mínimo	Finalidade
ARARAS/TITAN/VIGIAR	2019-2026; município e dia/semana	Calor, umidade, chuva, seca, focos, PM2,5, alertas, risco integrado, previsão e população exposta.	Antecipação, pré-posicionamento e acionamento climático.
SAMU/CBMMT/CIOPAER	2021-2026; ocorrência	Múltiplas vítimas, gravidade, tempos, recursos, destinos, transporte aéreo e dificuldades operacionais.	Módulo de trauma e logística de remoção.
Contratos e preços	Últimos 3-5 anos; item/contrato	Estruturas, geradores, gases, satélite, transporte, limpeza, resíduos, equipes, manutenção e mobilização.	Pesquisa de preços e custo total do ciclo de vida.

F.1 Regras de qualidade e proveniência

Regra	Aplicação
Identificadores	Código IBGE com sete dígitos; CNES preservado; identificador anonimizado para registros assistenciais.
Temporalidade	Datas no padrão AAAA-MM-DD; data e hora quando necessária; registrar competência e data de corte.
Ausência de dado	Usar N/A ou campo nulo; não converter ausência em zero.
Denominadores	Registrar leitos elegíveis, população, testes realizados e demais denominadores utilizados.
Versionamento	Guardar arquivo original, versão tratada, algoritmo/limiar, responsável e histórico de alterações.
Validação	Triangular fonte documental, sistema oficial e confirmação da área técnica responsável.
Proteção de dados	Remover nome, CPF, CNS, endereço e demais identificadores não necessários; aplicar controle de acesso e LGPD.
Reprodutibilidade	Entregar dicionário de dados, fórmula dos indicadores, filtros, exclusões e script ou consulta quando disponível.

F.2 Regra para atualização do ETP

Os dados públicos consolidados integram a justificativa atual. Após a recepção das bases internas, a equipe de planejamento deverá atualizar: a estimativa de acionamentos do item 14.1; os gatilhos de N1 a N4; a matriz regional de tempos rodoviários; a capacidade de leitos; os perfis de kits e equipes; e o cenário de consumo da pesquisa de preços. Toda atualização deverá manter a matriz de proveniência e registrar a aprovação das áreas responsáveis no Anexo E.

Encaminhamento

Submeta-se este documento-base à autoridade competente para constituição da equipe de planejamento e autorização do aprofundamento técnico, da consulta ao mercado e da pesquisa de preços.

_____ Equipe de Planejamento da Contratação	_____ Equipe de Planejamento da Contratação
Elaboração técnica	Aprovação da autoridade competente

Complementação técnica e normativa — revisão 2.1

Integra esta minuta como requisito de revisão. As escolhas propostas dependem de validação institucional; as referências não equivalem a aprovação da contratação.

1. Fundamentos e limites de aplicação

A Lei nº 14.133/2021 orienta planejamento (art. 18), estimativa de preços (art. 23), parcelamento de compras e serviços (arts. 40 e 47), cláusulas contratuais (art. 92), fiscalização (art. 117) e recebimento (art. 140). Aplicam-se o Decreto Estadual nº 1.525/2022 e alterações, com conferência da consolidação pela área jurídica. A inclusão no PCA deve observar os atos estaduais pertinentes, inclusive IN nº 002/2025/SEPLAG e sua alteração pela IN nº 003/2026/SEPLAG. A escolha de prontidão remunerada exige motivação própria; nenhuma dessas referências, isoladamente, aprova preço, modalidade, lote único ou contratação direta.

2. Necessidade, alternativas e dimensionamento

O ETP deverá comparar capacidade própria, locação com suporte, serviço integrado e aproveitamento de contratos ou capacidade existente, documentando investimento, custo anual, tempo de resposta, logística e risco de indisponibilidade. Para cada cenário, registrar fonte e data dos dados, população exposta, demanda provável e máxima plausível, capacidade operacional residual da rede, lacuna, duração e incerteza. Dimensionar a configuração para a lacuna demonstrada, sem usar capacidade cadastrada como sinônimo de capacidade disponível. Os números de leitos nas versões anteriores são referências de planejamento e não autorizam quantitativos ou preços.

3. Catálogo contratual e parcelamento

Antes do edital, cadastrar cada módulo e fornecimento com código, descrição, unidade, capacidade, dependências, preço, teto quantitativo, prazo e forma de aceite. Separar leito disponível de paciente atendido, exame de diária laboratorial e unidade de medicamento de reserva de estoque. A ativação modular não equivale, por si, a parcelamento da licitação. Justificar contratação conjunta ou separada de medicamentos, laboratório, estrutura e operação, avaliando competição, responsabilidade técnica, integração e custo de gestão. Não permitir inclusão de item novo ou ampliação ilimitada por simples OA.

4. Prontidão verificável e manutenção

O aceite inicial do NO exige inventário identificável, localização dos bens, estado de conservação, testes funcionais, plano de manutenção, capacidade de mobilização e responsáveis. Mensalmente, a empresa entregará posição do inventário, intervenções previstas e realizadas, falhas, substituições, reservas e evidência da capacidade garantida. A empresa executa e custeia manutenção preventiva e corretiva ordinária, calibração aplicável, peças e testes, inclusive sem missões, em preços já contratados. Definir contratualmente capacidade reservada, exclusividade ou compartilhamento admitido e resposta a missões simultâneas; não remunerar como exclusiva uma capacidade comprometida com terceiros. A RDC nº 509/2021 sustenta plano, registros e rastreabilidade; terceirizar a gestão não elimina a responsabilidade sanitária do estabelecimento.

5. Dossiê de decisão e limites da OA

O dossiê para o Secretário reunirá nota técnica assinada, evento e território, risco e cenários, insuficiência da rede, alternativas examinadas, configuração, dependências, cronograma, custo estimado, saldo contratual e disponibilidade orçamentária, além de recomendação de início, revisão e término. A decisão do Secretário e seus condicionantes serão anexados à OA identificada e datada. A formalização institucional dessa competência integra as providências prévias. A OA executa o objeto contratado e não substitui licitação, empenho, aditivo ou licença quando exigidos. Registrar reavaliações sempre que mudarem demanda, risco, acesso ou capacidade local.

6. Laboratório isolado e medicamentos isolados

Laboratório isolado terá escopo de exames, tipo de serviço, responsabilidade técnica, licenciamento aplicável, fluxo de amostras, controle de qualidade, conservação, comunicação de resultados críticos e destinação de resíduos. Adotar como referência regulatória a RDC nº 978/2025 e a alteração RDC nº 986/2025, conferindo o texto consolidado para o enquadramento concreto. Medicamentos isolados terão catálogo validado pela assistência farmacêutica, especificação, quantidade, rastreabilidade de lote, validade mínima justificada, conservação, transporte, registro de temperatura quando aplicável e fluxo de rejeição/recolhimento. A RDC nº 430/2020 e alterações apoia a logística farmacêutica conforme atividade. Não cobrar montagem, diária hospitalar ou desmontagem inexistentes.

7. Formação de preços, medição e vedação à duplicidade

A pesquisa de mercado deverá solicitar composição homogênea para N0, dez leitos, laboratório, medicamentos e missão combinada, incluindo distâncias e durações comparáveis. Separar reserva de estoque, aquisição, consumo e reposição; esclarecer titularidade e destino dos saldos. O mapa de custos indicará o que cada preço inclui. Na medição mensal, conciliar OA, boletim de execução, inventário, aceite, nota fiscal e histórico de pagamentos. Suporte compartilhado e manutenção ordinária não geram cobrança duplicada. Para insumos pagos por unidade entregue e aceita, não cobrar novamente reposição da mesma entrega. A continuidade do N0 durante a missão depende das obrigações que permanecem e da segregação de custos.

9. Matriz de riscos e continuidade

Atribuir à empresa falha ordinária de equipamento, manutenção vencida, conservação inadequada e perda por vencimento sob sua gestão; prever substituição e recomposição sem preço adicional ordinário. Identificar separadamente acesso bloqueado, sítio inadequado, falha de utilidades locais, demanda simultânea e atraso de licença, com responsável, prevenção, contingência, evidência e consequência contratual. A imputação dependerá da causa documentada e da alocação pactuada. Para assistência, prever referência e transporte seguro de pacientes; para laboratório, rede de apoio; para medicamentos, fornecedor e rota alternativos autorizados. O encerramento exige transferência assistencial, reconciliação de estoques e liberação do sítio.

11. Condições para concluir a versão de edital

Permanecem pendentes de decisão institucional: solução e parcelamento, modalidade e critério de julgamento, catálogo e limites, quantitativos sustentados por dados, preços pesquisados, reserva orçamentária, SLAs, matriz de riscos, licenciamento e ato de competência. Menções anteriores a modalidade, técnica e preço, faixas de leitos, prazos ou percentuais são propostas a harmonizar na versão final. Não declarar a contratação aprovada ou pronta para publicação antes dessas validações. As diretrizes OMS para equipes médicas de emergência são referência técnica complementar; N0–N4 é classificação interna do projeto e não representa classificação ou certificação OMS.

Referências da complementação

Brasil. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

Mato Grosso. SEPLAG. Portal de Aquisições Governamentais: legislação e atos do PCA. Disponível em: <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?c=4&pg=ver>. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. RDC nº 509, de 27 de maio de 2021. Gerenciamento de tecnologias em saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0509_27_05_2021.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Agenda de ARR 2023–2026: RDC nº 978/2025, alterada pela RDC nº 986/2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-do-resultado-regulatorio/agenda-de-arr-2023-2026>. Acesso em: 28 set. 2026.

Anvisa. Perguntas e respostas sobre a RDC nº 430/2020. Atualização de novembro de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/certificacao-e-fiscalizacao/perguntas-e-respostas/perguntas-e-respostas-rdc-430-de-2020.pdf>. Acesso em: 28 set. 2026.

World Health Organization. Classification and minimum standards for emergency medical teams. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/BlueBook2021.pdf>. Acesso em: 28 set. 2026.